

Niespójność *moralna*

Nie każdy „uzależniony od porno” jest uzależniony. U części osób problem to nie ilość, tylko konflikt z własnymi wartościami. Ten model wyjaśnia to inaczej.

CZAS: 30 min Psychoedukacja + autorefleksja

ŹRÓDŁO: Grubbs i wsp. (2019, 2020, JBA); Grubbs & Perry (2019)

JAK UŻYWAĆ

Model niespójności moralnej (ang. *moral incongruence, MI*) — wprowadzony przez Joshuę Grubbsa (Bowling Green State University). Pokazuje, że **postrzegane uzależnienie** od pornografii (ang. *perceived addiction*) jest często wynikiem nie ilości używania, tylko **konfliktu między używaniem a osobistymi/religijnymi wartościami**. Karta przedstawia: 1) co to znaczy, 2) różnicę między PPU klinicznym a MI, 3) jak rozpoznać u siebie, 4) dwa różne kierunki interwencji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Grubbs i wsp. (2019, *Journal of Behavioral Addictions*, n=2 075): **50-70% osób, które same siebie określają jako „uzależnione” od pornografii**, NIE spełnia kryteriów CSBD wg ICD-11. Co je odróżnia? *Wysoka religijność / konserwatywne wartości seksualne*. Dla tej grupy **cierpienie nie wynika z ilości**, tylko z konfliktu moralnego. Klasyczna terapia uzależnień (abstynencja, profilaktyka nawrotów) *nie pomaga* — czasem pogłębia wstyd. Pomaga: praca nad wartościami (ACT), refleksja nad źródłami norm, integracja seksualności. Stąd kluczowe rozróżnienie: **PPU kliniczne** vs **MI bez PPU** — wymagają innych interwencji.

01 Dwie różne sytuacje — PPU kliniczne vs niespójność moralna

PPU KLINICZNE (CSBD WG ICD-11)

- Używanie wysokie ilościowo (kilka godzin / dzień)
- Utrata kontroli — próby ograniczenia bez powodzenia
- Cierpienie funkcjonalne (praca, relacje, zdrowie)
- Utrzymuje się *niezależnie* od wartości
- Pacjent ateista też ma problem
- **Leczenie:** CBT, profilaktyka nawrotów, kontrola środowiska

NIESPÓJNOŚĆ MORALNA (MI)

- Używanie niskie lub umiarkowane (1x/tydz., 30 min)
- Kontrola obecna — można się powstrzymać
- Cierpienie pochodzi z *konfliktu wartości*
- Wysoka religijność / konserwatyzm seksualny
- Bez tych przekonań nie byłoby problemu
- **Leczenie:** ACT, praca z wartościami, edukacja seksualna

Możliwe są też kombinacje: niektórzy pacjenci mają *oba* — i wysokie używanie z utratą kontroli, i silny konflikt moralny. U nich potrzebne są **obie ścieżki interwencji** równoległe: praca z behawioralnym wzorcem + praca z wartościami.

02 Skąd bierze się niespójność — trzy źródła

1 · RELIGIA

Tradycyjne nauczanie chrześcijańskie, muzułmańskie, żydowskie ortodoksyjne, niektóre tradycje buddyjskie traktują masturbację i pornografię jako grzech lub przeszkodę duchową. To realne wartości — nie do bagatelizowania.

2 · WARTOŚCI SPOŁECZNE

Konserwatyzm seksualny niezwiązany z religią — np. lojalność wobec partnera, krytyka kapitalistycznej eksploatacji w branży porno, troska o przedstawicieli aktorów.

3 · RUCHY SPOŁECZNE

NoFap, „*semen retention*”, rebooting — ruchy popularne online. Często oparte na pseudonauce, ale mogą tworzyć autentyczne osobiste wartości u osoby, która do nich należy.

Klucz: w terapii MI *nie zmieniamy* wartości pacjenta — to byłoby narzucanie naszych preferencji. Pomagamy mu *zauważyć*, że źródłem cierpienia może być nie zachowanie, tylko konflikt z normami, i wspólnie zastanowić, czy te normy są dla niego *autentycznie ważne*, czy *odziedziczone bez refleksji*.

03

✎ Twoja diagnoza różnicowa — autoanaliza

ILE CZASU / RAZY W TYGODNIU UŻYWAM

— uczciwe oszacowanie

CZY PRÓBY OGRANICZENIA KOŃCZĄ SIĘ
POWODZENIEM

— gdy decyduję, że dziś nie — czy potrafię

CZY UŻYWANIE WPŁYWA NA PRACĘ / RELACJE /
ZDROWIE

— konkrety, nie ogólności

JAKIE WARTOŚCI MORALNE ŁAMIĘ UŻYWAJĄC

— skąd te wartości, czy są autentycznie moje

04

💡 Co z tego wynika dla mnie

BARDZIEJ ROZPOZNAJĘ U SIEBIE

— PPU kliniczne / MI / mieszanka

CO TO ZMIENIA W MOJEJ STRATEGII ZMIANY

— praca z zachowaniem / praca z wartościami / obie

Ważne — nie ma jednej „dobrej” odpowiedzi: jeśli Twoje wartości autentycznie sprzeciwiają się pornografii i utrzymujesz je z refleksji (nie pod presją), to *logiczne*, że chcesz zmienić zachowanie zgodnie z nimi. Terapia ACT pomaga to zrobić bez wstydu — kierując się wartościami, nie unikając ich. Jeśli natomiast wartości pochodzą z zewnętrznej presji (rodzina, kościół, internet) i nie rezonują z Tobą — może warto się nad nimi zastanowić. Nie ma tu jednej dobrej drogi — jest *Twoja* droga, której terapeuta pomoże Ci poszukać.

Klucz: Grubbs & Perry (2019, *Annual Review of Sex Research*) podkreślają, że **diagnoza PPU vs MI ma realne konsekwencje terapeutyczne**. Pacjent z czystą MI poddany klasycznej terapii uzależnień (skupienie na nawrotach, abstynencja jako jedyny cel) często doświadcza *pogłębienia wstydu* i mówi „*nawet z uzależnieniem nie potrafię sobie poradzić*”. Pomaga: 1) *walidacja wartości* bez ich kwestionowania, 2) ACT — działanie zgodne z wartościami, 3) edukacja seksualna w bezpiecznej przestrzeni, 4) refleksja nad źródłem norm. ICD-11 (2022) wyraźnie wyklucza diagnozę CSBD u osób, których cierpienie wynika wyłącznie z konfliktu moralnego — to nie zaburzenie psychiczne, to wybór wartości wymagający respektu.